

Fecha Última Actualización: 15-03-2022 13:56:32

Página 1 de 3

Información Paciente

Nombre : Arcenia Del Carmen Ibarra Ibarra
Edad : 77a 11m 17d
Dirección : Dvorak 2859 Dpto., 25 Villa Juanita

Rut : 4.949.904-3
Fecha Nacto: 26/03/1944
Comuna : Puente Alto

N° Archivo : 1025337
Sexo : Femenino
Teléfono : 9 4401 0718

N° Epicrisis
297699

Información Hospitalización

Unidad de Ingreso : Upc - Uci Adulto

Fecha Ingreso : 14/02/2022 17:24

Días Estadía: 29

Unidad de Egreso : Hospital De Campaña - Camas Básic

Fecha Egreso : 15/03/2022 14:00

Motivo o Diagnóstico de Ingreso

Disnea

Comorbilidades

Hipertensión Arterial;

Procedimientos

Intervenciones Quirúrgicas

Epidemiología

Resumen Clínico

Fecha Ingreso HSR 14/2/22
Fecha Ingreso UPC: 16/2/22
Fecha Ingreso UTIM 01/03/22
Fecha Ingreso sala: 03/03/22
Fecha Ingreso HC: 04/03/22

Anamnesis remota:

- Mórbidos: HTA, ICC.
- Quirúrgicos: hernioplastia inguinal, histerectomía total (por cáncer cervicouterino hace años).
- Medicamentos: nifedipino, losartán
- Alergias: no
- Hábitos: no
- Hospitalizaciones recientes: no
- Inmunizaciones: sin inmunización por COVID 19.
- Social: paciente desorientada, no se evalúa

Anamnesis:

Paciente con antecedentes descritos, consulta por cuadro iniciado el 03/02 caracterizado por rinorrea y odinofagia. Evoluciona con compromiso del estado general, tos productiva, dolor torácico, disnea y fiebre hasta 38°C. Consulta inicialmente con médico particular el 10/02, quien inicia corticoterapia, broncodilatadores y xarelto (no queda claro si inicia esta última terapia). Paciente reconsulta el 14/02 donde se pesquisa desaturación hasta 78% ambiental, por lo que es derivada al servicio de urgencia.

Ingresa en a REA en regulares condiciones generales, PA 171/95, FC 128 lpm, T° 36.4, FR 52(), Sat 91% con MAF 15 litros O2, HGT 123. Al examen físico de ingreso a reanimador se describe vigil, reactiva, MP (+), abundantes crépitos en ambos campos, uso de musculatura accesoria. Dentro de sus exámenes de ingreso destaca PCR 335, crea 0.86, BUN 15.2, ELP 135/3.15/100, Ca 9.1, alb 3.5, GSV pH 7.46, pCO2 30.9, HCO3 21.8, EB -1.9, BT 0.52, PCR SARS CoV-2 (+). Rx Tórax compatible con cuadro de neumonía viral con infiltrado difusos con mayor consolidación en 2/3 inferiores mayor a derecha.

Se indica aporte de potasio, ampicilina sulbactam y CNAF con requerimiento de flujo 60 lpm y FiO2 60% con regular respuesta

Fecha Epicrisis : 15/03/2022 13:56

Página 1 de 3

Fecha Última Actualización: 15-03-2022 13:56:32

Página 2 de 3

inicial. Se indica terapia depletiva por signos de congestión pulmonar.

Al control de exámenes de laboratorio 15/02 destaca Hto 45.2, Hb 14.8, GB 14880, RAN 13400, plq 396000, ácido láctico 18.6, ELP 138/3.40/104, GSA ph 7.459, pCO2 31.5, pO2 56.6, HCO3 21.8, EB -2.0 (FiO2 60%), PaFI 94.

Durante la noche del 15/02 evoluciona con signos de falla ventilatoria a pesar de aporte de CNAF. Se decide VMNI con mala respuesta, por lo que se intuba. AngioTAC Tórax no evidencia TEP, neumopatía viral por COVID extensa. Se traslada a UPC para continuar manejo.

Diagnósticos ingreso:

1-Insuficiencia Respiratoria Aguda Grave Hipoxemia

2-Neumonía COVID

a.PCR SARS CoV-2 (+) 14/2/22

b.FI síntomas 3/02/22

3-SDRA grave

4-Insuficiencia cardíaca (FEVI desconocida)

Se recibe a paciente hemodinámicamente inestable con requerimiento de Nad 0.12 ug/kg/min, normocardica, afebril, en SAS 1 acoplada a VM, con FiO2 100%, con BIC Fentanyl y Midazolam.

Evolución durante hospitalización:

1.Hemodinámico: Ingres a hemodinámicamente inestable con requerimiento de NAD. Ante sospecha de componente de insuficiencia cardíaca se manejó con terapia depletiva y vasodilatadora. Actualmente estable, con vasodilatadores orales para manejo de presión arterial. Ecocardiograma TT FE 62%, ventrículo izquierdo no dilatado, con función sistólica global y segmentaria normal, aurícula izquierda no dilatada sin trombos o masas, reflujo aórtico ligero degenerativo.

2.Respiratorio: Insuficiencia respiratoria catastrófica por COVID-19, con necesidad de pronó y BMN. Recibe 10 días de dexametasona. Evolución lenta pero favorablemente. Logra extubación el 28/02 con salida a CNAF. El 02/03 pasa a naricera, con requerimientos de oxígeno suspendidos el 06/03. Última imagen 25/02 con disminución de opacidades parenquimatosas, pero con signos de organización. Se mantiene kinesioterapia y broncodilatación.

3.Infeccioso: Ingres a por NAC por COVID-19 grave. En contexto de PPII elevados (PCR 330) asociado a radiografía de tórax con signos de posible sobreinfección pulmonar, se inició manejo con ampicilina sulbactam. CAET (+) E. coli multisensible. Completa tratamiento, sin embargo evoluciona nuevamente febril. Se inició cobertura amplia con vancomicina/imipenem, estudio destaca CAET 23/02 (+) E. coli + Aspergillus terreus, desestimando rol patológico de este último. TAC del 25/02 disminución de la extensión y grado de condensación de las opacidades parenquimatosas pulmonares bilaterales en el contexto de neumopatía multifocal conocida, con signos de organización. El 03/03 completa 7 días de tratamiento con Imipenem. UC (+) Enterococcus faecium Van B, solicitado por retención aguda de orina secundaria a retiro de sonda foley que resuelve posterior a volémización, impresiona bacteriuria asintomática. Afebril, parámetros inflamatorios a la baja.

4.Renal: Sin antecedentes de falla renal, cursó con hipokalemia recurrente que requirió múltiples cargas EV, sin causa clara. Evoluciona con buena función renal, sin alteraciones electrolíticas. Se indica retiro de sonda foley, con necesidad de sondeo intermitente transitoria, actualmente orinando espontáneamente.

5.Dermatológico: Paciente con placas eritematosas y descamativas en región del pañal y espalda. Evaluada por equipo de dermatología, impresiona dermatitis candidiásica. Se indica Fluconazol 150 mg 1 comprimido a la semana por 2 semanas (primera dosis recibida viernes 11/03) y cutanil pasta 2 veces al día por 14 días (hasta el viernes 25/03).

5.Rehabilitación:

-FNA: En seguimiento por equipo. Recibiendo régimen licuado + líquidos espesos. Asistido, pausado y sentada en 90°. Pese a no estar logrando los objetivos de ingesta, se indica retiro de SNG por odinofagia que puede estar interfiriendo en ingesta. Alta fonoaudiológica.

-Motor: Con KNT motora, logrando marcha dinámica con asistencia.

-Delirium: Recibiendo quetiapina para manejo de delirium, suspendido previo al alta.

Alta con hospitalización domiciliaria para continuar rehabilitación motora.

Diagnóstico de Egreso

Insuficiencia Respiratoria Aguda Resuelta - Neumonía Covid-19 + Navm Por E. Coli Tratada

Bacteriuria Asintomática Por Enterococcus Faecium Van B -

Obs. Icc Patrón Tibio-Húmedo Resuelta -

Trastorno De Deglución En Rehabilitación -

Fecha Epicrisis : 15/03/2022 13:56

Página 2 de 3

Fecha Última Actualización: 15-03-2022 13:56:32

Página 3 de 3

Miopatía Del Paciente Crítico En Rehabilitación -
Dermatitis Candidiásica En Tratamiento -
Hipertensión Arterial -

Condición de Egreso Alta Hosp. Domiciliaria

Egreso con Catéter Doble J:NO

Paciente en buenas condiciones generales, hemodinámicamente estable, afebril, sin requerimientos de oxígeno. Con buena tolerancia oral.
Deposiciones (+), diuresis (+).

Plan Post Alta

Alta con hospitalización domiciliaria para continuar rehabilitación motora.

Sin alergias conocidas.

Contacto: María Romero (hija) 9 3322 3788

1. Reposo relativo asistido
2. Régimen licuado + líquidos espesos + pan de molde, asistido, pausado y sentada en 90°, carraspear cada 2 cucharadas.
3. Medicamentos:
 - Losartán 50 mg al día vía oral
 - Carvedilol 12.5 mg cada 12 horas vía oral
 - Paracetamol 1 g SOS si dolor o fiebre, máximo cada 8 horas vía oral
 - Quetiapina 12.5 mg SOS si agitación severa vía oral
 - Cutanil pasta, aplicar en espalda y zona del pañal cada 12 horas hasta viernes 25/03 inclusive
 - Fluconazol 150 mg el día viernes 18/03 vía oral
4. Control:
 - Continuar controles de patologías crónicas en consultorio (hipertensión arterial).
5. Consultar al servicio de urgencias en caso de fiebre, dificultad respiratoria, pérdida de conciencia, desorientación o en caso de estimar necesario.
5. Iniciar esquema de vacunación COVID-19.

Indicaciones

Tipo de Reposo :

Régimen Alimentario :

Medicamentos :

Controles

INTERNO

Becado/Residente



Sofía Kutscher Campero

Médico Tratante (Staff)